

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		KONTRASEPSI MOW (METODE OPERASI WANITA)		
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		No. Dokumen 327/RSPHS/I-SPO/DIR/VI/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 12 Juni 2026	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep		
Pengertian	Tindakan kontap pada wanita disebut MOW (Metode Operasi Wanita) atau tubektomi, yaitu tindakan pengikatan dan pemotongan saluran telur agar sel telur tidak dapat dibuahi oleh sperma.			
Tujuan	Mengehentikan kehamilan			
Kebijakan	1. Pelepasan MOW hanya dilakukan atas indikasi medis dan/atau permintaan pasien setelah melalui konseling komprehensif. 2. Pasien wajib menandatangani informed consent. 3. Tindakan dilakukan oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang berwenang. 4. Pelaksanaan mengacu pada pedoman pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi nasional.			
Prosedur	1. Persiapan pasien : a. Puasa b. Laboratorium c. Darah k/p d. Posisi tidur terlentang e. Cateter f. Cukur g. Pasang infus h. Paket Anastesi 2. Persiapan alat: a. Set tubektomi b. Bowl umum c. Dram kassa d. Slang suction e. Rubber sheet f. Benang cromik 2/0 non ATR g. Cromik 1 non ATR h. Plain 2/0 ATR i. Polipropilin 3/0 ATR 3. Tubektomi a. Minta persetujuan tindakan medic b. Cuci tangan steril c. Antisepsis daerah operasi dan sekitarnya d. Lakukan pembiusan oleh dokter spesialis anastesi e. Infiltrasikan lidokain 1% ke sub kutis dibawah umbilikus f. Jepit ujung lateral kanan dan kiri kulit di bawah umbilikus dengan menggunakan kocher g. Angkat kedua kocher tinggi-tinggi, tusukkan ujung pisau bedah pada ujung lateral kanan, setelah menembus kulit, tarik pisau bedah ke ujung kiri dengan satu gerakan h. Masukkan bilah retraktor kemudian lepaskan kocher dan tarik retractor ke arah atas dan bawah sehingga tampak fasia			

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	KONTRASEPSI MOW (METODE OPERASI WANITA)		
	No. Dokumen 327/RSPHS/I-SPO/DIR/VI/2026	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	i. Jepit fascia-peritoneum dengan arah atas bawah kemudian gunting fascia-peritoneum di antara kedua koher j. Masukkan ujung gunting pada sayatan fascia-peritoneum, perlebar guntingan fascia-peritoneum ke lateral kanan dan kiri sehingga visualisasi rongga abdomen menjadi lebih baik k. Dengan ujung bilah retraktor , tarik fascia-peritoneum, lepaskan kedua koher, lakukan orientasi lapangan operasi l. Orientasi dilakukan dengan menggeser retraktor & mendorong dinding lateral uterus. Kenali uterus, tuba dan sekitarnya m. Gerakkan retraktor ke kiri & dinding lateral kiri uterus ke arah medial sehingga tampak kornu dan tuba kiri. Bila gagal menampilkan tuba, gunakan pengait tuba. Bila tidak tersedia pengait tuba, pakai jari telunjuk untuk menampilkan tuba n. Jepit tuba dengan menggunakan pinset anatomis panjang. o. Telusuri tuba hingga mencapai mencapai fimbriae p. Setelah dipastikan tuba, ambil bagian tengah (pars isthmika) dengan klem Babcock dan keluarkan dari kavum abdomen melalui luka insisi q. Lakukan pengikatan tuba secara angka delapan (lengkung tuba hingga ikatan berjarak 1,5-2 cm) dengan simpul kunci r. Potong tuba di antara simpul dan jepitan Babcock (perhatikan hemostasis ikatan) s. Bila ikatan baik dan tidak ada perdarahan, potong benang 0,5 cm dari simpul ikatan t. Kembalikan tuba kiri ke tempatnya semula, atur kembali Gerakan retraktor dan dinding lateral uterus sehingga dapat Menampilkan tuba kanan. Ulangi langkah yang sama pada Tuba kanan hingga selesai. u. Setelah kedua tuba diikat dan dipotong dan dikembalikan ke dalam kavum abdomen, bersihkan sisa darah pada dinding perut. Lihat kembali kondisi dalam rongga perut. Keluarkan Kassa gulung (jika dipakai) atau instrument v. Pindahkan bilah retraktor pada kulit, angkat retraktor, lalu jepit fascia-peritoneum dengan koher pada 2 tempat (kraniol dan kaudal) w. Lakukan penjahitan fascia-peritoneum secara terputus dengan benang kromik no. 1/0 x. Bersihkan luka operasi dan kulit dengan larutan antiseptic jahit kulit secara subkutikuler dengan kromik no 3/0 y. Mencuci tangan z. Lakukan pengawasan pasca tindakan 4. Melakukan pendokumentasian dalam rekam medis dan mencatat dalam register KB		
Unit Terkait	1. Poli Kandungan 2. Maternitas 3. IKO		